五、治疗

1.首选**根治性手术切除肝段或肝叶**（**解剖**性肝切除术），术后**残留肝储备功能**是手术成败的关键，一般认为手术必须满足下列条件之一：

避免手术后出现肝衰竭

①肝功能 Child-Pugh A 级、吲哚菁绿 15 分钟滞留率＜30%（绿帽子-小三）残留肝储备功能好,可代谢吲哚菁绿,不会滞留

②剩余肝脏体积须占标准肝脏体积 30%以上（无肝纤维化）或 40%以上（有肝纤维化）

病例题:Child-Pugh C级禁止手术,Child-Pugh A/B级都可以做手术
若只考这个知识点,只能回答Child-Pugh A级

9 版《外科学》手术指征：小五外面找小三

①无肝外转移

②最适合单发≤5cm 的微小肝癌和小肝癌

③若为单发的大肝癌或巨大肝癌，应要求其向肝外生长（破坏肝组织＜30%）、肿瘤包膜完整（周围界限清楚）

④若为多发肿瘤，应要求肿瘤结节数目少于 3 个且局限在肝的一段或一叶内

⑤**若肝功能 Child-Pugh C 级（黄疸+腹水）先不手术**，可 TACE、保守治疗，待肝功能好转后再手术

黄水

2.不符合手术指征选择 **TACE**，部分不适合一期手术者经此方法可获得手术机会

3.消融

肿瘤脱水变性坏死

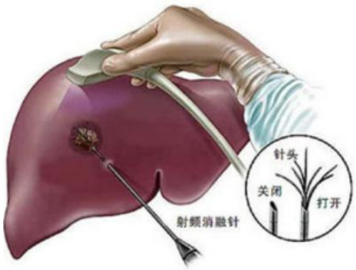
①包括：射频 RF、微波、经皮穿刺瘤内注射无水酒精 PEI、高强度聚焦超声消融

②可用于单个肿瘤≤5cm、或 2-3 个肿瘤最大≤3cm 且又不宜手术者，特别是肝切除术后早期复发者

4.肝移植

①合并肝硬化的患者在肝移植后可消除肝硬化、减轻门脉高压相关表现和并发症

②若肝癌已侵犯大血管和肝外转移者**不宜**肝移植



5.分子靶向药：多激酶抑制剂（索拉菲尼）等（肝索）

抑制蛋白激酶(信号转导通路-生长)→抑制肿瘤生长

6.**肝癌破裂大出血**的治疗

①急诊 **TAE 或 TACE**、或急诊**肝切除术** 不是TAC:化疗不能止血

②病情危急、术中情况不允许者先立即行**纱布填塞**止血

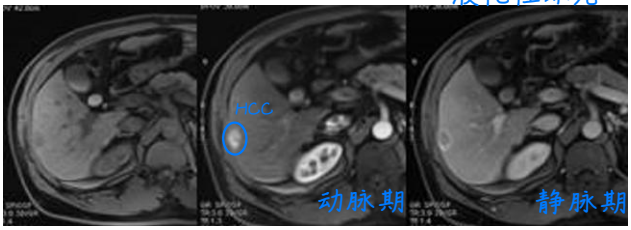
肝癌治疗大原则:能手术就手术(小五外面找小三),不能就选TACE

专题串联·肝脏疾病影像学

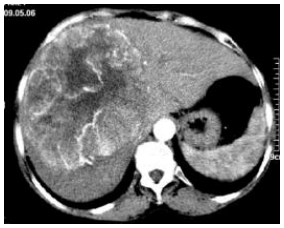
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

HCC	**快进快出**：动脉期明显强化、静脉期强化退去
胃肠道癌转移至肝	**牛眼征**：边缘明显强化 VS 肝脓肿:脓肿壁是肉芽组织(富含血管)→明显强化
肝血管瘤	灯泡征、早出晚归征（造影剂向心性填充 ttsx）
肝囊肿	**不强化** 无血管
肝脓肿（急性）：**高热**、WBC↑	液气平，动脉期楔形强化+边缘明显强化

液化性坏死



MRI





牛眼征:外面肿瘤细胞血供丰富(强化),越靠里面血供越不丰富,强化由强变弱到不强化(坏死)

牛眼征反映了肿瘤的异质性
异质性:肿瘤自己和自己比(亚克隆)
异型性:与正常组织相比(分化程度)